

العلاقة بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي وسط تلاميذ مرحلة الأساس الحلقة

الثالثة قطاع الثورة غرب محلية كرري ولاية الخرطوم

عبد الله، فاطمة يحيى¹ زين، بخيتة محمد² أحمد، علي فرح³

1. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

2. استاذ مشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

مستخلص :

هدفت الدراسة الحالية إلى التأكد من وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ بمرحلة الأساس (الحلقة الثالثة) بمحلية كرري قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم، التعرف على الفروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ تبعاً لمتغير (النوع، العمر، الصف الدراسي، التحصيل الدراسي). استخدم الباحثون في هذه الدراسة المنهج السببي المقارن، وتم تطبيق مقياس الصحة النفسية من إعداد هيو أم بلوتمبل وفي مجتمع الدراسة بلغ عدد المدارس (43) مدرسة وبلغ عدد التلاميذ (4186). أما عينة الدراسة فقد تم إختيار (10) مدارس بواقع (5) مدرسة بنات و(4) مدارس بنين و(1) مدرسة مختلطة، أما من حيث حجم عينة التلاميذ فقد بلغت (100) تلميذ وتلميذة بواقع (36) تلميذ و(64) تلميذة وتم إختيار العينات بالطريقة العشوائية البسيطة. تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي: أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن الصحة النفسية للتلاميذ في مرحلة الأساس بمحلية كرري بولاية الخرطوم تتسم بالإخفاض، كما أظهرت وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لديهم، وأظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لديهم تبعاً لمتغير النوع (ذكر، أنثى) لصالح النوع (أنثى)، وأظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لديهم تبعاً لمتغير (الصف الدراسي، التحصيل الدراسي)، وفي ضوء النتائج الواردة تم التوصل إلى عدد من التوصيات أهمها: العمل على تجنب الأسباب التي تؤدي إلى تدهور الصحة النفسية للتلاميذ بقدر الإمكان وتوعية المجتمع بالآثار النفسية الناتجة من تدهور الصحة النفسية على الأطفال.

الكلمات المفتاحية: الصحة النفسية، التحصيل الدراسي، التلاميذ، ولاية الخرطوم

Abstract:

The study aimed at examining the existence of relationship between the Mental health of and academic achievement among pupils who were in the basic stage the third circle in Karari locality, Al Thawra sector west in Khartoum state, also identifying Statistically significant differences in the mental health of the pupils at the Basic stage the third circle in Karari locality, Al Thawra sector west in Khartoum state, identifying Statistically significant differences in the mental health of the pupils at basic stage the third cycle : in Karari locality, Al Thawra sector west in Khartoum state, according to the variables (gender, age, academic grade and educational background). In their study, the researchers used the comparative , and the study population consisted of pupils whose mothers have been divorced in the basic stage, the third circle in Karari locality, Al Thawra sector west in Khartoum state The number of government schools was (43). The number of students was (4186), and as for the study sample, (10) schools were selected, with (5) schools of girls and (4) of boys The total number of pupils was (100) including 36 males and (64) female pupils . The samples were chosen randomly. The most important findings of the study are: The results of the

statistical analysis showed that the mental healths of the pupils whose mothers have divorced at the basic stage, in Karari locality, Al Thawra sector west in Khartoum state is characterized by: decrease, and showed a positive correlation with statistical significance between mental health and their academic achievement, and showed that there were statistically significant differences according to the variables (gender, age, academic grade and educational background), and in the light of the results received a number of recommendations were reached the most important of which are: Avoiding the causes that lead to the deterioration of the mental health of pupils and educating the community about the psychological impact resulting from the deterioration of mental health on pupils.

The Key Words: the Mental health, academic achievement, The pupils, Khartoum state.

مشكلة الدراسة:

إن تناول شريحة مهمة وواسعة في المجتمع كمرحلة الأساس هو أمر ليس بالهين ورغم أنها تشكل قطاع واسع وكبير في المجتمع وأن الفرد فيها يكون في نهاية الطفولة وبداية المراهقة وهي من أهم مراحل النمو. لأن الطفولة تعتبر من المراحل الهامة في مرحلة تكوين الشخصية وكل ما يمر به الطفل من خبرات وتعلم ستظهر آثاره في سلوكه وشخصيته.

من خلال اضطلاع الباحثين على عدد من الدراسات السابقة وجدوا أن معظم الدراسات تتفق على أن هناك مشكلات أسرية تؤثر في التحصيل الدراسي، وأيضاً في الصحة النفسية وأيضاً بحكم عملهم كمدرسين نفسانيين ومراقبين في مدارس مرحلة الأساس وجدوا كثيراً من المشاكل في القطاع ومن هذه المشكلات مشكلة الدراسة الحالية والتي تسعى للتعرف على العلاقة بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ مرحلة الأساس ولاية الخرطوم محلية كررى.

وفي ضوء ما تقدم تكمن مشكلة الدراسة الحالية في محاولة الإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ مرحلة الأساس (الحلقة الثالثة) بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

1. هل تنسم الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس (الحلقة الثالثة) بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم بالإنخفاض؟

2. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس (الحلقة الثالثة) بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير الصف الدراسي؟

3. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس (الحلقة الثالثة) بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي؟

أهمية الدراسة:

1. تأتي أهمية الدراسة الحالية من أهمية الأسرة والتلميذ ومشكلة الصحة النفسية التي تلعب دور كبيراً في العملية التعليمية وأثرها على التحصيل الدراسي.

2. إبراز أهمية ترابط الوالدين للقيام بالدور المنوط بهم من تربية وتعليم لأبنائهم.

3. أهمية الاهتمام بشريحة تلاميذ مرحلة الأساس التي تمثل لبنة كل المجتمع.

أهداف الدراسة:

1. التعرف على السمة العامة للصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس (الحلقة الثالثة) بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم.
2. التعرف على الفروق ذات الدلالة الإحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس (الحلقة الثالثة) بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير الصف الدراسي.
3. التعرف على الفروق ذات الدلالة الإحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس بمحلية كررى بولاية الخرطوم تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي.

فروض الدراسة:

1. تتسم الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس (الحلقة الثالثة) بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم بالإنخفاض.
2. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس (الحلقة الثالثة) بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير الصف الدراسي.
3. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس (الحلقة الثالثة) بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي.

حدود الدراسة:

الحدود الزمانية: (2018-2022)

الحدود المكانية: مرحلة الأساس (الحلقة الثالثة) بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم.

الحدود البشرية: التلاميذ بمرحلة الأساس (الحلقة الثالثة) بمحلية كررى قطاع الثورة غرب بولاية الخرطوم.

الاطار النظري:

أولاً: الصحة النفسية:

الصحة النفسية تعتبر من أكثر المواضيع الحيوية التي تشغل فئات المجتمع المختلفة وذلك لأن الصحة بشقيها النفسي والجسدي تعتبر أهم قيمه يسعى الجميع إلى توفير أكبر قدر منها حتى يظل فردا متفاعلا في مجتمعه الكبير ، وعندما يمس موضوع الصحة بشقيها النفسي والجسدي شريحة الطلاب يكون الموضوع أكثر أهمية واشد حساسية من غيره من المواضيع والأسرة هي راعية الطالب ومعلمته الأولى لجميع أنماط السلوك ، كذلك المدرسة التي تأتي بعد الأسره إذ تتعهد هذا الطالب بالرعاية والتنشئة والتطوير في جميع نواحي شخصيته المعرفيه ، والمهارات الإخلاقية والروحية ثم اقتصاديا وبين مجتمعا ويقوى مؤسساتها ويربى عنها الأجيال وهذا لا يتأتى مالم يتوفر لدى الطالب القدر المطلوب من الوعي النفسي والحضور الذهني والنشاط العقلي والصحة بشقيها الروحي والجسدي أوالنفسي .

ولكى يصل التلميذ إلى القدر الذى يجعل المجتمع يطمئن على صحته النفسية وتكثر الإجهادات حول معنى الصحة النفسية عندما نقف أمام مشكلة اضطرابات السلوك بمعنى آخر عندما تقابل سلوك غير سوى إلى المعيار الشائع للسلوك ، فى مجتمع من المجتمعات عندما نوجه هذا السلوك الغير سوى ونرغب فى تعريفه وتحديد معالمه نجد أنفسنا أمام تعريف المواد كنموذج للسلوك نقرب عنه أو نبتعد عنه بنسب متفاوتة (أحمد، سهير كامل، 2003، ص54-55).

للصحة النفسية معاني وتعريفات متعددة سنعرض لأهمها بغية الوصول إلى تعريف يمكن أن نستعين به فى رسم السبل المؤدية إلى سلامة العقل ، والمحافظة عليه من التعرض للاضطرابات السلوكية بأشكالها المختلف.

مفهوم الصحة النفسية: الصحة النفسية كما عرفها القوصي بأنها التوافق التام بين الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة الأزمات النفسية الحادة ، التي تطرأ عادة على الإنسان مع الإحساس الإيجابي بالسعادة والكفاية. (شحاته ، محمد ، 2006م ، ص15)

عرفها (صفوت فرج) الصحة النفسية هي حالة من الانسجام الجسمي والنفسي والاجتماعي التام ولا نعني مجرد غياب الأمراض والعجز أو الضعف ، وهذا يعنى التعريف إنسانا معافى فى النفس والجسم ومتوافقاً مع مجتمعه.

بينما يرى (القوصي) بأنها التوافق بين الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة الأزمات النفسية العادية التي تطرأ على الإنسان مع الإحساس الأيجابي بالسعادة والكفاية

وهذا يعنى خلو الأمر من النزاع الداخلى كوقوعه بين إتجاهين مختلفين كان يتردد بين تحقيق كرامته فى نظر نفسه وإشباع جوعه عن طريق السرقة. (الخطيب ، احمد حامد، 2003م ، ص 115-116)

يرى (عبدالمطلب القريطى) أن الصحة النفسية السليمة بأنها حالة عقلية إنفعالية إيجابية مستقرة نسبيا تعبر عن تكامل طاقات الفرد ووظائفه المختلفة وتوازن القوى الداخلية والخارجية المواجهة لسلوكه فى مجتمع ووقت ومرحلة معينة وتمتعه بالعافية النفسية والفاعلية الاجتماعية والصحة النفسية وفقا لهذا التعريف هي حالة مستقرة نسبيا أي تتسم بالدوام النسبي يمكن أن يبلغها كما أنها حالة عقلية إنفعالية مما ترتبط بالجوانب الأخرى كالجانب الجسمي وهذا لأيعنى أنتقاء العلاقة بين النفس والجسم فكلاهما يتفاعل مع الآخر ويؤثر فيه ويتأثر به. (عبد الغنى، 2002م ، ص 24)

ويرى (كيلادر) الصحة النفسية هي التي تقاس بمدى قدرة الإنسان على التأثرفى بيئته وقدرته على التكيف مع الحياة بما يؤدي بصاحبه إلى قدر معقول من الإشباع النفسي والكفاءة والسعادة. (داؤد، عبدالبارى، 2006، ص 25)

لذلك فالصحة النفسية هي إنعدام الأمراض النفسية والإتجاه إلى السلوك السوى وعلى بساطة هذا التعريف إلا أننا نواجه فيه بعض الصعوبات وهي:

1. أن السلوك السوى يصعب تحديده فهو يختلف من جماعة جماعة حسب التقاليد السلوكية السائدة كما تختلف من فرد إلى آخر.
2. أن الأطباء النفسيين يتدربون على إكتشاف السلوك غير السوى وليس على تقدير السلوك السوى الأمر الذى يصعب معه تحديدهم للسلوك السوى نتيجة لقلّة التدريب فسلوك شرب الخمر ، ترفضه بعض الجماعات وتقبله الجماعات الأخرى وحتى فى الجماعات التي تقبل سلوك شرب الخمر ، فإنها تميز بين سلوك شرب الخمر الإجتماعي الذى يقبله المجتمع وسلوك شرب الخمر الذى لا يقبله المجتمع ويعتبره سيئة أو مرضا يعالج.

كل هذا يجعل من الصعب تحديد أنماط السلوك السوى بشكل نهائى ولعل هذا النقص هو الذى دفع الأطباء النفسيين فى هذه الآونة إلى محاولة الدراسة المقارنة للسلوك القوم للجماعات المختلفة.

وفى هذا التعريف فإن الصحة النفسية هي أن يكون الإنسان طبيعيا ويفترض أن الإنسان فى العادة يكون سوياً وأن السواء بهذا ظاهره عامة وعلى هذا فإن السلوك يكون فى حدود الطبيعى عندما لاتوجد مؤشرات على سلوك شاذ والصحة ولهذه الصورة هي الممارسة الطبيعية للحياة وتعتبر المرض هو الإنحراف عن مسار الصحة. (التيممي، محمود كاظم، 2016م ، ص 54-55)

تتمثل أهمية الصحة النفسية للمجتمع فيما يلى : (جردان ، فتحي ، 2001م ، ص 21-22) :

1. الصحة النفسية عنصر مهم فى تحقيق التكيف الإجتماعي.
2. تساعد فى قدرة الفرد على قبول الواقع بعلاقاته مع محيطه.
3. تساهم فى زيادة إنتاج المجتمع.

4. تساهم بشكل إيجابي في الحياة الاجتماعية بجوانبها المختلفة كالتعلم والصحة والاقتصاد والسياسة، فكلما كان العاملون في هذه المجالات متمتعين بصحة نفسية جيدة كان الأداء إيجابياً.

5. المساهمة في بناء أسر مستقرة والتي تعتبر أساس البناء الاجتماعي

تهدف الصحة النفسية الى مايلي: (التميمي ، محمود كاظم ، 2016م ص7) :

1. مساعدة الفرد على التوافق مع نفسه ومع غيره ومع البيئة المحيطة به.

2. مساعدة الفرد على أن يكون إنساناً سوياً يتمتع بقدر كبير من الصحة النفسية.

3. أن يكون الفرد قادراً على السيطرة على مواقف الإحباط.

4. أن يكون الفرد قادراً على مواقف الصراع بين الغرائز والضمان

من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإهتمام بالصحة النفسية مايلي:(منسى ، حسن 2001م ، ص 22-24) :

1. السعى المفرط لإشباع الرغبات والحاجات والجرى وراء النزوات أي أن الرفاهية المادية لدى الأفراد وتوفير كل ما يرغبونه أدى إلى تدمير نفسياتهم وشعور هؤلاء الأفراد بالوفرة المادية الزائدة على حساب الأمن العقلي والنفسي ، مما أدى إلى السأم والملل من حياتهم إذ أن الحياة دون تعب لاتعنى السعادة فكان لابد من وجود الإهتمام بالصحة النفسية لديهم.

2. معالجة آثار الحرمان الذي يترجم إلى سلوكيات غير مرغوب فيها لبعض أولئك المحبطين والمحرومين من المشاركة في الحياة العامة أو السياسية أو صنع القرار داخل الأسرة أو المدينة أو المجتمع إذ أن إهمال هذه الفئة يدفعها إلى إثبات الذات وتأكيدا عن طريق السلوكيات السلبية غير الأمرغوب فيها مما يؤدي إلى إعاقة العمل والبناء للمجتمع بل وأيذاء الآخرين.

خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية: تتميز الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية بعدة خصائص تميزها عن الشخصية

المريضة وفيما يلي : (لطفى ، وأحلام حسن ، 2007م ص 13) :

أ. القدرة على تحقيق التوافق السوي.

ب. الشعور بالسعادة مع النفس.

ج. مدى إستمتاع الفرد بعلاقاته الاجتماعية.

د. تحقيق الذات وإستغلال القدرات.

و. القدرة على مواجهة مطالب الحياة(ملحم،سامي، 2007م، ص48).

العلاقة بين الصحة النفسية والمدرسة:

العلاقة بين الصحة النفسية والمدرسة علاقة وثيقة وأن تفضيلات حياة التلاميذ داخل المدرسة حافلة بالخبرات التي تؤثر سلباً أو إيجاباً على الصحة النفسية للتلاميذ وحتى لوأخذنا التعليم بمعناه الضيق التقليدي بأنه مجرد التحصيل الدراسي والهدف الأساسي للمدرسة لتبين لنا أن هناك علاقة وثيقة بين الصحة النفسية من جهة والتحصيل من جهة أخرى (الجبالي ، حمزة، 2006، ص26).

إن التلميذ الذي يعاني من القلق أو المشغول الذهني بمشكلاته الإنفعالية وعدم قدرته على تكوين علاقات إجتماعية مع أقرانه بالمدرسة سيصعب عليه التركيز على شرح المدرس لأن معظم طاقته وجهوده يتم إستنفادها لأنشغاله بمشكلات إنفعالية وسيقود ذلك إلى تأخره الدراسي وحل ما يطلب من تدريبات وواجبات سيؤدي به تأخره الدراسي إلى الشعور بالنقص وفقدان الثقة بالنفس وسيترتب على هذا كله أشكال من السلوك الشاذ مثل الهروب من المدرسة خوفاً من العقاب والانضمام إلى أقران السوء وهذا بداية الإنحراف والسلوك اللاإجتماعي و أن هذه الإستجابات السيئة يمكن تلافيها من قبل المدرس إذا ما وجه إهتمامه بتلاميذه المتأخرين ويوضح لهم ماغرض من موضوعات لثم إدراك أهمية الرعاية والتوعية النفسية للمدارس وأثرها في التقدم الدراسي

لتلاميذه ونمو شخصياتهم يتبين لنا إذاً مدى التأثير المتبادل بين صحة التلميذ النفسية وبين التعلم المدرسي (عبدالخالق ، أحمد، 2001م، ص26).

ثانياً- التحصيل الدراسي: التحصيل الدراسي هو أحد الأبعاد التربوية ذات الأهمية البالغة لكل تلميذ ويعتبر مدخلا من مداخل إثبات الذات وتحقيقها ، حيث يرى أصحاب التربية أن مستوى التحصيل الأكاديمي هو علامة من علامات ومؤشرات نجاح العملية التربوية والتعليمية ، بالنظر إليه كأحد العوامل المهمة والتي لها دور في نمو الذات.

وتستعمل كلمة التحصيل لتشير إلى التحصيل التعليمي ولأنك أن التحصيل الأكاديمي يجعل التلميذ يتعرف على قدراته وامكانياته ووصله إلى مستوى تحصيلي مناسب ، ويبين الثقة في التلميذ ويعزز مفهومه عن ذاته ويبعد عنه القلق والتوتر مما يقوى صحته النفسية ، أما فشله في التحصيل الدراسي فإنه يؤدي إلى عدم الثقة بالنفس والإحساس بالإحباط والنقص مما يؤدي إلى القلق والتوتر وهو من دعائم سوء الصحة النفسية للتلميذ وكذلك يتأثر سلوك الفرد وأداؤه بمفهومه عن ذاته، والتحصيل الأكاديمي باعتباره نوع من الأداء يتأثر مفهوم التلميذ عن ذاته فنظرة التلميذ إلى نفسه كشخص قادر على التحصيل والنجاح في تعليمه المدرسي تعمل كقوة منشطه تدفعه إلى تأكيد هذه النظرة والحفاظ عليها (عسكر ، عبدالله، 2005، ص35) .

مفهوم التحصيل الدراسي: التحصيل الدراسي يتمثل في المعرفة التي يحصل عليها التلميذ من خلال برنامج أو منهج مدرسي قصد تكيفه مع الوسط والعمل المدرسي ويقتصر هذا المفهوم على ما يحصل عليه الفرد المتعلم من معلومات وفق برنامج معد يهدف إلى جعل المتعلم أكثر تكيفاً مع الوسط الاجتماعي الذي ينتمي إليه بالإضافة إلى إعداده للتكيف مع الوسط المدرسي بصورة عامة (عبدالعزيز ، مفتاح ، 2010م، ص56) .

تعريفات التحصيل الدراسي:

يشتمل مفهوم التحصيل الدراسي على مكونات أساسية هي:

1. مجموع المعارف التي يستوعبها التلميذ خلال عملية التعلم ويستطيع توظيفها في جوانب مختلفة في الحياة اليومية (حمدان ، مجمد ، 1996م، ص57) 0.
2. التحصيل ادراسي هو مستوى مجدد من الانجاز أو البراعة في العمل المدرسي يقاس من جانب المعلمين أو بالاختبارات المقدروالمقياس الذي يعتمد عليه (سعد ، يحي ، 2022م، ص 22) 0.
3. هو بلوغ مستوى معين من الكفاءة في الدارسة سواء كان في المدرسه ، أو الجامعة ويتم تحديد ذلك من خلال العديد من الاختبارات (أحمد ، عمر ، 2019م ، ص 42) 0

العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي :

1. المعلم: للمعلم دور أساسي ومباشر في مستوى الطلبة وتحصيلهم أما إيجاباً أو سلباً وذلك من خلال قدرته على التنويع في أساليب التدريس ومدى مراعاته للفروق الفردية بين الطلبة ، وحالته المزاجية العامة ونمط الشخصية ومدى قدرته على تعميم الاختبارات التحصيلية بطريقة جيدة وموضوعية وعدم التساهل في توزيع العلامات بما لا يتناسب وما يستحقه التلاميذ. (حمدان ، محمد، 1996، ص57)

2. المتعلم نفسه: ضعف الصحة وسوء التغذية والعاهات الخلقية هي العوامل التي تحد من قدرة الطفل على بذل الجهد ومسايرة زملائه في الفصل.

والإستعداد الدراسي هو مدى قابلية الفرد للتعلم أو مدى قدرته على إكتساب سلوك أو مهارة معينة إذا ما تهيأت له الظروف المناسبة. والإستعداد العام كما حدده جانية (1985) وهو الحالة التي يكون فيها المتعلم مستعداً من الناحية العضوية للنجاح في أداء المهمات التي يتوقع مصادفتها في المؤسسة التعليمية ، ويتحدد هذا الإستعداد بسن دخول المدرسة وفي أغلب البلدان هي سن

ست سنوات. وأما الإستعداد الخاص للمتعلم فيتحدد بتوفير خبرات سابقة من أجلها أن تساهم في بناء خبرات جديدة ولذلك ينبغي للمعلم أن يتحرى مدى توافر هذه الخبرات السابقة عند تلاميذه وذلك قبل تقديم الخبرة الجديدة. (النور، أحمد يعقوب، 2006 ، ص72)

العوامل المتعلقة بالبيئة المدرسية والأسرية: قد يؤدي الحرمان والكبت وعدم إستقرار العائلة أو تصدعها إلى ضعف في التحصيل وأن جو الأسرة في حد ذاته يعد من أهم أسباب التخلف الأكاديمي فقد يؤدي الشجار بين الوالدين أو تحريض بعض الأطفال من طرف الأم أو الأب ضد الطرف الآخر أو الإهمال والتدليل والقمع المستمر لرغبات الطفل إلى التأثير على تحصيله الأكاديمي، بل يؤدي به إلى أحضان الجناح والإنحراف، ويرجع إنخفاض مستوى التحصيل الأكاديمي إلى عوامل ترجع إلى الوالدين والأسرة وهناك عدد من العوامل التي تساعد على حدوث الإضطراب السلوكي للأطفال ، وأن كانت ترجع في أساسها إلى الوالدين وليس للطفل نفسه وهذه العوامل هي: (المرض النفسي، السلوك الإجرامي في الأسرة، لتفاعل بين الطفل والديه، الانفصال بين الوالدين والطلاق والإختلافات الزوجية، تدني المستوى الإقتصادي والإجتماعي للأسرة، الترتيب الميلادي للطفل وحجم الأسرة) (رضاء وفاء منذر، 2005، ص384) .

العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي: يذكر آدم(2005) أن هنالك عدة عوامل تؤثر في عملية التحصيل الدراسي أهمها: أولاً- العوامل الخارجية: وهي البيئة المحيطة بالطالب .

ثانياً- العوامل الداخلية: وهي الخصائص المعرفية والنفسية للطالب التي تميزه عن غيره وتعد هذه العوامل مهمة في زيادة مستوى التحصيل الدراسي للطالب (بسماء، ادم، 2005، ص902).
أساليب التحصيل الدراسي الجيد:

يقال إذا أريد الحصول على تذكر جيد فلا بد أن يكون هنالك تعلم جيد أولاً فالتعلم الجيد هو الذي يجعل الذاكرة منظمة ومرتبطة ومنسقة أكثر قدرة على إحتزان المعلومات وإسترجاعها عند اللزوم، وهذه المبادئ التي توصل إليها علماء النفس والتربية والتي تجعل التعلم إذا توفرت تعلماً وتحصيلاً جيداً(عثمان، أحمد2005، ص100) .
أهمية التحصيل الدراسي:

يعتبر التحصيل الدراسي محور الإهتمام الرئيسي في عمليات التربية والتعليم والدراسة العلمية، كما يعد المسار الأساسي للمفاضلة بين الأفراد في مؤسسات الدولة التعليمية ، ويعتبر أيضاً من أهداف العملية التعليمية التربوية والتي تعطينا صورة متكاملة لسير التعليم وذلك لأنه يقود إلى تركيز ما تعلمه ويعمل كحافز معزز للمزيد من التعلم (خيرالسيد، 2007، ص16).
والتحصيل الدراسي من المتغيرات المعقدة والمرتبطة بالعديد من المتغيرات الأخرى والتي يحاول الباحثون الكشف عن طبيعتها ودرجة ارتباطها ؛ وذلك لأهميتها من الناحيتين النظرية والتطبيقية ، فالكشف عن وجود علاقة بين النجاح في الشهادة الثانوية ، والتحصيل الدراسي في الجامعة مثلاً ليس مفيداً في تحديد هذه العلاقة فحسب بل استخدام هذه العلاقة بالتنبؤ المستقبلي للطالب.
(حقي، الفت2000، ص40)

أساليب التحصيل الأكاديمي: إن عملية التحصيل الأكاديمي عملية ليست بسيطة بل تعتبر من أكثر العمليات التعليمية تعقيداً وتسهم فيها كثيراً من العمليات العقلية التي بدورها تنمي قدرة الطالب في إستيعاب المادة إلكاديمية ، ومن هذه العمليات العقلية الآتية: (الإدراك، التذكر) (الروافضة ، 2004 ، ص35).

ضعف التحصيل الدراسي: ليس من السهل الإتفاق على تعريف واحد لضعف التحصيل الدراسي لقد إنقسم الباحثون إلى قسمين : عند تعريف ضعف التحصيل الدراسي القسم الأول: يعتمد على ضعف الذكاء في تحديد معنى ضعف التحصيل. أما القسم الثاني: يعود إلى العوامل البيئية (المادية والإجتماعية) ويقدر مدى ضعف التحصيل الدراسي معتمداً على الدرجات التي يحصل

عليها التلميذ في الاختبارات المدرسية ومن ثم القول بأن أهم العوامل التي يتفق عليها الباحثون على الرغم من الاختلافات بينهم هي العوامل العقلية (خاصة نسبة الذكاء) والعوامل النفسية والجسمية والاجتماعية وبهذا يمكن تلخيص معنى ضعف التحصيل الدراسي بأنه عدم إكمال النمو التحصيلي نسبة لعوامل عقلية أو جسمية أو نفسية أو إجتماعية (عطية، 1995، ص 99) . أسباب ضعف التحصيل:

(ضعف الصحة العامة، ضعف البصر والسمع والنطق، ضعف الذكاء العام، الفقر المادي في المنزل، فقدان التوازن العاطفي، عدم المواظبة والحماس لحضور الدراسة (العيصوي، عبدالرحمن محمد 2004، ص 82). علاقة التقويم بالتحصيل الأكاديمي:

يمثل التقويم حجر الزاوية لإجراء أي تطوير أو تجديد تروى يهدف إلى تحسين في عملية التعليم والتعلم في أي مجتمع فالتقويم التربوي يهتم في معرفة درجة تحقق الأهداف الخاصة بعملية التعليم، ويسهم في الحكم على سوية الإجراءات والممارسات المتبعة ، ويوفر قاعدة من المعلومات التي تلزم متخذى القرارات التربوية حول مدخلات وعمليات ومخرجات المسيرة التعليمية.(وجيه، وآخرون 2002، ص 234). ترى الباحثة أن الأسباب الإقتصادية وتدهور إقتصاديات الأسرة يؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي بالنسبة للتلميذ وكذلك الأسباب النفسية والتوترات التي تؤدي إلى إنحراف التلميذ عن الصحة النفسية والقلق والخوف والحرمان من أحد الوالدين.

الدراسات السابقة:

تعتبر الدراسات السابقة بمثابة النواة لأي دراسة بحثية وعلى ضوءها يتم تحديد الفروض والمسلمات وفي هذا البحث يتم عرض بعض الدراسات ذات الصلة بمتغيرات هذه الدراسة ولقد صنف الباحثون الدراسات السابقة الى ثلاث اقسام وهي الدراسات السودانية والدراسات العربية والدراسات الأجنبية وفيمايلي عرض لهذه الدراسات :

تعتبر الدراسات السابقة بمثابة النواة لأي دراسة بحثية وعلى ضوءها يتم تحديد الفروض والمسلمات وفي هذا الدراسة يتم عرض بعض الدراسات ذات الصلة بمتغيرات هذه الدراسة .

1. دراسة : وفاة حمزة (2004) بعنوان أوضاع الصحة النفسية وأثرها في التحصيل الدراسي لتلاميذ مرحلة الأساس جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بحث مقدم لنيل درجة الماجستير . هدفت إلى التعرف على أوضاع الصحة النفسية وأثرها في التحصيل الدراسي لتلاميذ مرحلة الأساس جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ومن أدوات الدراسة: استخدمت الباحثة الإستبانة والملاحظة والمقابلات الشخصية، تكونت من عينة قوامها (150) معلم ومعلمة من مرحلة الأساس للبنين والبنات. أوضحت نتائج الدراسة التالي: الصحة النفسية لتلاميذ مرحلة الأساس تنسم بالإيجابية من وجهة نظر المعلمين. توجد علاقة ارتباطية موجبة بين الصحة النفسية والصحة المدرسية، توجد فروق ذات دلالة إحصائية في واقع الصحة المدرسية بين مدارس البنين والبنات لصالح مدارس البنات..

2. دراسة: أمة الرازق (2003م) بعنوان الصحة النفسية وعلاقتها بالضغوط النفسية ، جامعة صنعاء هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الصحة النفسية لدى طلبة جامعة صنعاء والتعرف على العلاقة بين الصحة النفسية والضغوط النفسية وشملت عينه الدراسه (409) طالب وطالبة واستخدمت الباحثة مقياس الصحة النفسية ومقياس الضغوط النفسية ووضحت النتائج أن النسبة الأكبر من طلاب جامعة صنعاء يقعون في منطقة السلامة النفسية كما اوضحت وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والاناث في معظم ابعاد الصحة النفسية وكانت الفروق

3. دراسة : سماح أحمد السلطي (2015م) بعنوان مستوى الصحة النفسية لدى عينة من الطلبة المتفوقين دراسيا في محافظة دمشق وعلاقتهم ببناتهم الإنفعالي هدفت الدراسه الى الكشف عن مستوى الصحة النفسية والثبات الإنفعالي لدى عينه من الطلبة

المتفوقين دراسيا في محافظة دمشق والتعرف على العلاقة بين الصحة النفسية والثبات الإنفعالي وشملت عينة الدراسة (288) طالب وطالبة من المتفوقين دراسيا بالمرحلة الثانوية واستخدمت الباحثة مقياس الصحة النفسية ومقياس الثبات الإنفعالي من إعدادها وأوضحت النتائج: وجود مستوى مرتفع من الصحة النفسية لدى الطلبة المتفوقين في محافظة دمشق كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الصحة النفسية وفقا لمتغير الجنس لصالح عينة الذكور الذكور أعلى في مستوى الصحة النفسية من الإناث .

4.دراسة : الزبير(2015)هدفت الى معرفة العلاقة بين الأمن النفسي والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ المكفوفين بمركز النور جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تحت مقدم لنيل درجة الماجستير , بلغ حجم العينة 60 تلميذ وتلميذة استخدمت المنهج الوصفي الارتباطي واستخدمت مقياس الأمن النفسي وكذلك التحصيل الدراسي وتوصلت النتائج الى : الأمن النفسي يتسم بالارتفاع ولا توجد فروق فردية إحصائية داله في الأمن النفسي تعزى لمتغير النوع , ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير مستوى الصف الدراسي , ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير العمر , وتوجد علاقة ارتباطية بين الأمن النفسي والتحصيل الدراسي .

5.دراسة montiro (2004م) التي استهدفت تحديد برنامج مدرسي للصحة النفسية وعلاقته بالتحصيل الأكاديمي تكونت العينة من (216) طالبا من إحدى المدارس الثانوية في كاليفورنيا شاركوا في البرنامج وخضعوا لمدة تتراوح بين 9-36 اسبوع لجلسات العلاج النفسي مثل أساليب تعديل السلوك -بناء التقدير الذاتي -المهارات الإجتماعية -التواصل وحل المشكلات وأسفرت النتائج : عن وجود فروق موجه ذات دلالة إحصائية بين البرنامج المدرسي للصحة النفسية والتحصيل الدراسي : تعليق على الدراسات السابقة تناولت الباحثة فيما سبق مجموعه من البحوث والدراسات ذات التشابه والتقارب بمادة الدراسة الحالية رغم تباين وتعدد أنواعها فقد توصلت الى نتائج هامة وبرزها التي تناولت التحصيل الدراسي وانعكاسه على الصحة النفسية فقد أوضحت ان الاستجابة لحالة الطفل للدف والحنان هي على قدر كبير من الاهمية والتاثير في نموه النفسي وتنوعت الدراسات السابقة في إجراءاتها وأهدافها التي سعت الى تحقيقها وفئة العينة العمريه وعلى أفرادها وأدواتها المستخدمة في جمع المعلومات والاساليب الاحصائية والنتائج التي توصلت اليها ومن حيث المنهج .

منهج وإجراءات البحث الميدانية:

منهج البحث:

قام الباحث في هذه الجزئية باستخدام المنهج السببي المقارن والذي تعتبره هو الأنسب في هذه الدراسة وذلك لأن المنهج السببي المقارن يتيح فرصه لوصف الظاهرة وصفاً علمياً دقيقاً وذلك بجمع المعلومات عن موضوع البحث عن طريق جمع البيانات لكي يصل إلى حل المشكله قيد الدراسة (كمال وسعيد عثمان, 2010م , ص44).

المجتمع الأصلي للبحث: يتكون المجتمع من تلاميذ وتلميذات مرحلة الأساس ولاية الخرطوم محلية كررى قطاع الثورة غرب الحلقة الثالثة تعليم حكومي.عينة البحث: اختار الباحثون مرحلة الأساس باعتبارهم هم اللبنة الأولى للمجتمع . استخدموا أسلوب العينة العشوائية البسيطة لمدارس محلية كررى قطاع الثورة غرب الحلقة الثالثة المتمثلة في (43) مدرسة وقد تم إختيار (10) مدارس بواقع (5) مدرسة بنات (4) مدرسة بنين و(1) مدرسة مختلطة وحجم العينة (100) تلميذ وتلميذة بواقع (36) تلميذ و(64) تلميذة وتم إختيار المدارس بطريقة عشوائية وتم جمع الإستبيان بنسبة (100%).

وصف عينة البحث:

1. الصف:

الجدول رقم (1) التوزيع التكراري لمتغير الصف

المتغير	التكرار	النسبة المئوية
السادس	2	2.0%
السابع	55	55.0%
الثامن	43	43.0%
المجموع	100	100.0%

عينة الدراسة كانت 10 مدارس بالطريق العشوائية (100) تلميذ وتلميذه ، مكتب تعليم الثورة غرب ، محلية كررى ، ولاية الخرطوم، 2021م

يتضح من الجدول السابق أن في متغير الصف إحتل الصف (السابع) النسبة الأعلى من بين باقي النسب بنسبة (55.0%)، يليه في المرتبة الثانية الصف (الثامن) بنسبة (43.0%)، يليه في المرتبة الثالثة الصف (دبلمعالي) بنسبة (10.0%)، في حين إحتل المرتبة الدنيا الصف (السادس) بنسبة (2.0%) لكل منهما.

2. التحصيل الدراسي:

الجدول رقم (2) التوزيع التكراري لمتغير التحصيل الدراسي

التحصيل الدراسي	التكرار	النسبة المئوية
ممتاز	2	2.0%
جيد جداً	19	19.0%
جيد	30	30.0%
مقبول	23	23.0%
ضعيف	26	26.0%
المجموع	100	100.0%

يتضح من الجدول السابق أن في متغير التحصيل الدراسي إحتل التحصيل الدراسي (جيد) النسبة الأعلى من بين باقي النسب بنسبة (30.0%) يليه في المرتبة الثانية التحصيل الدراسي (ضعيف) بنسبة (26.0%)، يليه في المرتبة الثالثة التحصيل الدراسي (مقبول) بنسبة (23.0%)، يليه في المرتبة الرابعة التحصيل الدراسي (جيد جداً) بنسبة (19.0%) في حين إحتل المرتبة الدنيا التحصيل الدراسي (ممتاز) بنسبة (2.0%).

أدوات البحث:

1. مقياس الصحة النفسية من إعداد (هيو إم بل) وكان من رسالة (صالح 2004 م)

2. نتيجة تحصيل التلاميذ نهاية العام .

أولاً: مقياس الصحة النفسية:

قام الباحثون بإجراء دراسة إستطلاعية على عينة من مجتمع الدراسة للتأكد من صدق وثبات الإستبانة على عينة الدراسة المختارة لموضوع البحث ومعرفة مدى ملائمة الأدوات لواقع وعينة البحث. ثم طبقوا الإستبانة، ومن خلال توزيعهم للعينة وركزت على ضرورة الإجابة عن جميع فقرات الإستبانة وعدم وضع أكثر من إجابة لفقرة الواحدة .

الصدق الظاهري لمقياس الصحة النفسية:

يعتبر صدق المحكمين أو الصدق الظاهري هو أن أداة القياس صادقة لما يدعى أنها تقيسه ويشير إلى مدى مناسبة المقياس للغرض الذي وضع من أجله ومدى تمثيله للجوانب التي وضع لقياسها مقياساً لصدق الاختبار. قام الباحثون بعرض المقياس على مجموعة من المحكمين، وقد قاموا بتقديم بعض الملاحظات وعلى ضوءها عمل الباحثون على تعديل بعض الفقرات.

وصف مقياس الصحة النفسية قبل التعديل:

يتكون من (38) عبارة أو فقرة كل فقرة على صورة سؤال يتضمن الإجابة (أوافق بشدة، أوافق، أوافق إلى حد ما، لا أوافق، لا أوافق بشدة) يميل الأفراد الذين يحصلون على درجات عالية إلى أنهم موافقين بشدة على السؤال وتدل الدرجات الدنيا إلى أنهم غير موافقين بشدة على السؤال.

الخصائص السيكمترية لمقياس الصحة النفسية قبل التعديل:

1. صدق فقرات مقياس الصحة النفسية:

وللتثبت من صدق فقرات مقياس الصحة النفسية حسب معامل ارتباط (بيرسون K. Person) بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمقياس الإكتئاب، وبعد التطبيق اتضح أن جميع فقرات المقياس البالغة (38) فقرة صادقة في قياس ما أعدت لقياسه إذ كانت معاملات ارتباطها بالدرجة الكلية دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (0.01) ومستوى دلالة (0.05)، حيث كانت القيم الاحتمالية لها أقل من مستوى الدلالة (0.01) ومستوى دلالة (0.05).

2. صدق مقياس الصحة النفسية قبل التعديل:

من خلال التثبت من صدق فقرات مقياس الصحة النفسية حسب معامل ارتباط (بيرسون) بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية وبعد التطبيق اتضح أن جميع فقرات مقياس الكفايات المهنية البالغة (38) فقرة صادقة في قياس ما أعدت لقياسه إذ كانت معاملات ارتباطها بالدرجة الكلية دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (0.01) ومستوى دلالة (0.05)، حيث كانت القيم الاحتمالية لها أقل من مستوى الدلالة (0.01) ومستوى دلالة (0.05)، وبما أن علاقة الفقرة بالدرجة الكلية تعني أن المقياس يقيس سمة واحدة، إذن فصدق فقرات المقياس تعني أن المقياس صادق في قياس ما وضع من أجله، وعلى ضوء ذلك فإن مقياس الصحة النفسية صادق في قياس ما وضع لقياسه.

3. ثبات مقياس الصحة النفسية قبل التعديل:

أ. حساب ثبات مقياس الصحة النفسية باستخدام معادلة الفاكرونباخ (Olvakronba):

وللتثبت من ثبات المقياس استخدمت الباحثة في حساب الثبات معادلة (الفاكرونباخ)، حيث تعد معادلة (الفاكرونباخ) من أساليب إستخراج الثبات. وقد إستخرج الباحثون الثبات باستخدام هذه الطريقة ، حيث بلغت قيمة معامل الثبات لمقياس الصحة النفسية (0.741)، وهذا يشير إلى أن المقياس يتمتع بثبات جيد.

جدول (3) نتائج إختبار ألفا كرونباخ لمقياس الصحة النفسية قبل التعديل

عدد الفقرات	قيمة معامل ألفا كرونباخ
38	.741

4. الصدق التجريبي لمقياس الصحة النفسية قبل التعديل:

وعلى ضوء حساب قيمة معامل (ألفا كرونباخ) البالغة (.741) فإن الصدق التجريبي للمقياس يساوي (.861). وهو الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وهذا يشير أيضاً إلى أن مقياس الكفايات المهنية يتمتع بصدق عالي.

الخصائص السيكومترية لمقياس الصحة النفسية بعد التعديل:

1. صدق فقرات: مقياس الصحة النفسية بعد التعديل:

وللنتيجه من صدق المقياس حسب معامل ارتباط (بيرسون) بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمقياس الصحة النفسية، وبعد التطبيق اتضح أن جميع فقرات المقياس البالغة (30) فقرة صادقة في قياس ما أعدت لقياسه إذ كانت معاملات ارتباطها بالدرجة الكلية دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (.01) ومستوى دلالة (.05) حيث كانت القيم لإحتمالية لها أقل من مستوى الدلالة (.01) ومستوى دلالة (.05). أنظر الجدول (12).

2. صدق مقياس الصحة النفسية بعد التعديل:

من خلال التثبت من صدق فقرات مقياس الصحة النفسية حسب معامل ارتباط (بيرسون) بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية وبعد التطبيق اتضح أن جميع فقرات المقياس البالغة (30) فقرة صادقة في قياس ما أعدت لقياسه إذ كانت معاملات ارتباطها بالدرجة الكلية دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (.01) ومستوى دلالة (.05) حيث كانت القيم لإحتمالية لها أقل من مستوى الدلالة (.01) ومستوى دلالة (.05). أنظر الجدول رقم (12).

وبما أن علاقة الفقرة بالدرجة الكلية تعني أن المقياس يقيس سمة واحدة، إذن فصدق فقرات المقياس تعني أن المقياس صادق في قياس ما وضع من أجله، وعلى ضوء ذلك فإن مقياس الصحة النفسية صادق في قياس ما وضع لقياسه.

3. ثبات مقياس الصحة النفسية بعد التعديل:

وللنتيجه من ثبات المقياس استخدم الباحث في حساب الثبات معادلة (ألفا كرونباخ)، حيث تعد معادلة (ألفا كرونباخ) من أساليب إستخراج الثبات. وقد إستخرج الباحث الثبات بإستخدام هذه الطريقة حيث بلغت قيمة معامل الثبات العام (.734). وهذا يشير إلى أن المقياس يتمتع بثبات عالي.

جدول (13) نتائج إختبار ألفا كرونباخ لمقياس الصحة النفسية بعد التعديل

عدد الفقرات	قيمة معامل ألفا كرونباخ
30	.734

4. الصدق التجريبي لمقياس الصحة النفسية بعد التعديل: وعلى ضوء حساب قيمة معامل (ألفا كرونباخ) البالغة (.734) فإن الصدق التجريبي للمقياس يساوي (.857). وهو الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وهذا يشير أيضاً إلى أن مقياس الصحة النفسية يتمتع بصدق عالي.

عرض ومناقشة النتائج:

عرض نتيجة الفرضية الأولى: (توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم)

الفرضية الصفرية $H_0 - Null Hypothesis$: تعني عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم.

الفرضية البديلة $H_1 - Alternate Hypothesis$: تعني وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم. لقياس العلاقة الارتباطية بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون لتحديد درجة الارتباط بين بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم الجدول رقم (21) يوضح ذلك:

جدول رقم (4) نتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد درجة الارتباط بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم

العلاقة بين	معامل ارتباط بيرسون	القيمة الاحتمالية	مستوى الدلالة
الصحة النفسية والتحصيل الدراسي	.358**	.000	.01

نلاحظ من الجدول أعلاه أن قيمة معامل ارتباط بيرسون قد بلغت (.358) وأن القيمة الاحتمالية لمعامل ارتباط بيرسون كانت مقدارها (.000) وهي أقل من مستوى الدلالة (.01). إذن نرفض تقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ المطلقات أمهاتهم بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ المطلقات أمهاتهم بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم، وهذا يشير إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ المطلقات أمهاتهم بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم.

مناقشة وتفسير نتيجة الفرضية الأولى:

من خلال التحليل الإحصائي تأكد صحة الفرض القائل بوجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم.

اختلفت هذه النتيجة مع دراسة السنهوري (1999) التي توصلت نتائج دراستها إلى أنه توجد فروق غير جوهريّة بين أبناء الآباء المطلقين وأبناء الآباء غير المطلقين في درجات الصحة النفسية وهذا الفرق لأبناء المطلقين وكذلك توجد فروق جوهريّة للتحصيل الدراسي بين أبناء الآباء المطلقين وأبناء الآباء غير المطلقين لصالح أبناء غير المطلقين.

عرض نتيجة الفرضية الثانية: (توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير الصف الدراسي)، لحساب الفروق في الصحة النفسية لدى التلاميذ مرحلة الأساس بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير الصف الدراسي (السادس، السابع، الثامن)، قام الباحث بحساب تحليل التباين لإحادي، الجدول رقم (5) يوضح ذلك:

الجدول (5) نتائج تحليل التباين لإحادي (ANOVA) للفروق الصحية النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير الصف الدراسي

مصدر التباين S.V	مجموع الأمربعات S.S	درجات الحرية D.F	متوسط الأمربعات M.S	القيمة الفائنية F	القيمة لإحتمالية Sig
بين المجموعات	671.408	1	671.408	2.432	.125
داخل المجموعات	13529.298	49	276.108		
الكلية	14200.706	50			

يبين الجدول (5) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير الصف الدراسي (السادس، السابع، الثامن)، وذلك استناداً إلى قيمة (F) المحسوبة لمتغير الصف الدراسي (2.432)، وقيمتها لإحتمالية التي تساوي (.125) وهي أكبر من مستوى الدلالة (0.05) مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ مرحلة الأساس بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير الصف الدراسي.

مناقشة وتفسير نتيجة الفرضية الثانية:

من خلال التحليل الإحصائي تأكد عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير الصف الدراسي.

اتفقت هذه النتيجة مع دراسته مع دراسة الزبير التي توصلت نتائجها إلى : توجد فروق ذات دلالة إحصائية داله في الأمن النفسى تعزى لمتغير الصف الدراسي واختلفت مع دراسته الشيخ التي توصلت نتائجها إلى : ان طلبة الفرقه الأولى والثانية أقل توافقا من طلاب الفرقه الثالثه والرابعه

عرض نتيجة الفرضية الثالثة: (توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي)

لحساب الفروق في الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي (ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول، ضعيف)، قام الباحث بحساب تحليل التباين لإحادي، الجدول رقم (25) يوضح ذلك:

الجدول (6) نتائج تحليل التباين إلاحادي (ANOVA) للفروق الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي

مصدر التباين S.V	مجموع الأمرينات S.S	درجات الحرية D.F	متوسط الأمرينات M.S	القيمة الفائنية F	القيمة لإحتمالية Sig
بين المجموعات	908.155	4	227.039	.786	.540
داخل المجموعات	13292.551	46	288.969		
الكلية	14200.706	50			

يبين الجدول (6) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ مرحلة الأساس بمحلية كررى بولاية الخرطوم تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي (ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول، ضعيف)، وذلك استناداً إلى قيمة (F) المحسوبة لمتغير التحصيل الدراسي (.786)، وقيمتها لإحتمالية التي تساوي (.540). وهي أكبر من مستوى الدلالة (0.05) مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ مرحلة الأساس بمحلية كررى بولاية الخرطوم تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي.

مناقشة وتفسير نتيجة الفرضية الثالثة: من خلال التحليل الإحصائي تأكد عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي.

وفي أدبيات البحث يقال أننا إذا أردنا أن نحصل على تذكر جيد فلا بد أن يكون لدينا تعلماً جيد أولاً فالتعلم الجيد هو الذى يجعل الذاكرة منظمة ومرتبطة ومنسقة أكثر قدرة على إحتزان المعلومات وإسترجاعها عند اللزوم، وهذه المبادئ التى توصل إليها علماء النفس والتربية والتى تجعل التعلم إذا توفرت تعلماً وتحصيلاً جيداً (عثمان، أحمد 2005، ص 100). نتائج الدراسة: كانت النتائج التى توصلت إليها الدراسة الحالية كما يلي:

1. توجد علاقة إرتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ بمرحلة الأساس بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم.
2. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ مرحلة الأساس بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير الصف الدراسي.
3. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الصحة النفسية لدى التلاميذ مرحلة الأساس بمرحلة الأساس الحلقة الثالثة بمحلية كررى قطاع الثورة غرب في ولاية الخرطوم تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي.

التوصيات:

1. تفعيل دور الأخصائيين النفسيين فى المدارس وإتاحة المجال أمامهم للقيام بواجباتهم وتفهم دورهم لمدراء المدارس.
2. العمل على برامج توجيه وتوعية وإرشاد نفسى لكى تعمل على الصحة المدرسية بصفة عامة والصحة النفسية بصفة خاصة وتحسين التعامل بين مديرى المدارس والمعلمين.
3. الإهتمام والرعاية بالتلميذ داخل المدرسة وخارجها.

المقترحات:

1. إجراء دراسات مستقبلية بأساليب علمية حديثة لإيجاد حلول مناسبة لدرء العوامل النفسية التي تؤثر على التحصيل الدراسي للتلاميذ.
2. ضرورة عمل دراسات تساهم في عملية تعميق التواصل ما بين المدرسة والمجتمع للمشاركة في الحلول التي تساهم في رفع المستوى التحصيلي للتلاميذ.

المصادر والمراجع:

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: المراجع:

- أحمد، سهير كامل، (2003م)، التوجيه والإرشاد النفسي للصغار، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر. 2- أحمد، عمر (2019م)، التحصيل الدراسي أهميته وأنواعه والعوامل المؤثرة فيه 0
- بابكر، ناهد محمد، (2000م)، الصحة النفسية لدى التلاميذ المعاقين سمعياً وعلاقتها بتحصيلهم الدراسي في ضوء مفهوم الذات، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان الإسلامية - السودان .
- التميمي، محمود كاظم محمود، (2016م)، مؤشرات في الصحة النفسية، دار المنهجية للنشر والتوزيع، الأردن.
- جردان، فتحى، (2001م)، تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات، دار الطليعة للطباعة والنشر، الأردن.
- الجبالي، حمزة، (2006م)، مشاكل الطفل والمراهق النفسية، دار أسامة للمشر والتوزيع، عمان، الأردن.
- حقي، إلفت، (2000م)، سيكولوجية الطفل، مركز الإسكندرية للكتاب.
- حامد، موسى مكي، (2013م)، القبول الاجتماعي المدرسي وعلاقته بالتوافق الإنفعالي والتحصيل الدراسي لدى طلاب المرحلة الثانوية بولاية جنوب كردفان، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
- حمدان، محمد، (1996م)، التحصيل الدراسي مفاهيم ومشاكل وحلول، دار التربية الحديثة، دمشق.
- الحفني، عبد المنعم، (1987م)، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، مكتبة مدبولي، القاهرة .
- الخطيب، أحمد حامد، (2003م)، التبول اللاإرادي أسبابه وطرق علاجه.
- خير السيد، محمد أحمد، (2007م)، التفوق والتأخر الدراسي وعلاقتهما بالقلق والإكتئاب وتقدير الذات لدى طلاب جامعة القصارف، رسالة دكتوراة، غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .
- داؤد، عبد الباري محمد، (2006م)، التربية النفسية للطفل، أيتراك للنشر والتوزيع، مصر .
- رضا، وفاء منذر، (2005م)، مشاكل طفلك النفسية، مكتبة المجمع العربي، عمان، الأردن .
- الروافضة، عبد المجيد على، (2004م)، أثر كل من طريقتي إلإسقاء وإلإلغاء على التحصيل وإكتساب مهارات التفكير لدى طلاب المستوى الثالث في مدارس التهذيب في السعودية، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية جامعة النيلين.
- سعد، يحي (2022م) التحصيل الدراسي مفهومه وأهميته وأنواعه والعوامل المؤثرة فيه.
- شحاته، محمد، (2006م)، أصول الصحة النفسية، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة .
- عطية، خطاب، (1995م)، أصول التربية وعلم النفس، دار النهضة الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة .
- عثمان، أحمد، علم النفس التربوي، (2006م)، جامعة السودان المفتوحة السودان.
- عبد الخالق، أحمد محمد، (2001م)، أصول الصحة النفسية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية .
- عسكر، عبدالله، (2005م)، الإضطرابات النفسية للأطفال، مكتبة الأنجلو، مصر

- عبدالغني، أشرف محمد ،(2002م)، الصحة النفسية بين النظرية والتطبيق، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية
- عبدالعزیز ، مفتاح ،(2010م)، علم نفس الصحة ، دار وائل للنشر
- لعيسوى ، عبدالرحمن محمد ، (2004م) ، الصحة النفسية من المنظور القانوني ، بيروت .
- لطفي ، سامية ومحمود ، أحلام حسن ،(2007م)، الصحة النفسية والمدرسية للطفل ، مركز الإسكندرية للكتاب ، مصر .
- ملحم ، سامي محمد ، (2007م)، المشكلات النفسية عند الأطفال ، دار الفكر العربي ، عمان .
- منسي ، حسن ، (2001م)، الصحة النفسية ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، أريد .
- النور ، أحمد يعقوب ،(2006م) ، علم النفس التربوي ، مكتبة جامعة السودان .
- وجيه ، إبراهيم وآخرون ،(2008م)، التقويم التربوي، جامعة الإسكندرية للنشر والتوزيع ، القاهرة
- ثالثاً: الرسائل والمجلات والدوريات:
- رابعاً: الشبكة العنكبوتية (الإنترنت):
- آدم، بسماء ، (2005م) ، قضية مدرسة وبيت ومجتمع ... التحصيل الدراسي ، موقع بلاغة كوم، إنترنت.
- <https://www.google.com/search?q=%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%AA.&aqs=chrome..69i57.8330j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>